Vereenvoudigd opgeschreven 7 stap

Casus 3 – Week 2 Studiehandleiding – Blok 1.4

N. medianus laesie t.g.v. snijwond trauma (7 weken geleden) met reconstructie van pezen en zenuw

Personalia: Dhr. Q.R, chirurg, 44 jaar

Zijn verhaal:

Ik ben heel erg blij dat de operatie goed gelukt is. De revalidatie duurt lang, maar ik merk dat het steeds iets beter gaat. Mijn handfunctie is sterk verbeterd. Mijn duimspieren zijn echter nog duidelijk verzwakt. Ook voelt mijn duim en wijsvinger nog 'dovig' aan. Ik werk goed samen met mijn fysiotherapeut en doe trouw mijn oefeningen. Ik wil weer terug naar de operatietafel! Op dit ogenblik doe ik alleen nog maar consulten. Ik ben ervan overtuigd dat ik volledig zal herstellen.

Ter introductie

Maak voor het invullen van de 7 stap gebruik van het RPS formulier (**R**ehabilitation **P**roblem **S**olving). Voor tekst en uitleg van het RPS formulier zie: https://youtu.be/1CdQvUrHOKM.

Maak bij het invullen van de 7 stap ook gebruik van het ICF systeem http://www.rivm.nl/who-fic/in/ICFwebuitgave.pdf

Tabel 1 - Overzicht 7 Stap

Stap 1 – Onduidelijke termen	Alle onduidelijke termen uit de casus zoek je op en beschrijf je hier.
Stap 2&3 – Definiëer het probleem (de klacht)	Een gezondheidsprobleem (de klacht) is veelal complex, hier zoek je uit wat de ICF categorieën zijn in de casus.
Stap 4 – Het gezondheidsprobleem	Hoe zit het gezondheidsprobleem in elkaar? Je hebt in stap 2 en 3 ICF categorieën gevonden van het gezondheidsprobleem, nu moet je relaties aangeven tussen deze categorieën en nagaan welke medisch biologische processen hieraan ten grondslag liggen. In deze stap zoek je ook uit wat de behandelbare grootheden voor de fysiotherapeut zijn.
Stap 5 – Diagnostisch proces	Nu je begrijpt wat het gezondheidsprobleem is, kun je hier aangeven op welke wijze je het diagnostisch proces gaat uitvoeren.
Stap 6 – Therapeutisch proces	Nu de fysiotherapeutische diagnose/conclusie duidelijk is, stel je een behandelplan op met duidelijke doelen en kun je verantwoorden welke interventie(s) je wilt in zetten.
Stap 7 – Effect van therapie	Ten slotte bedenk je, in biopsychosociaal opzicht, welke effecten het therapeutisch proces heeft gehad op de fysiologische en mentale eigenschappen.

Stap 1 Onduidelijke termen

Vermeld onduidelijke termen uit de casus met de betekenis ervan.

Onduidelijke term 1	Uitleg van onduidelijke term
Onduidelijke term 2	idem

Stap 2 & 3 Definieer het probleem (de klacht)

Persoonsgegevens (bij aanmelding)
Geslacht, leeftijd, beroep, hobby.

Verwijzing
De tekst van de verwijzing door een arts (indien aanwezig).

Patiëntencategorie
Is het gezondheidsprobleem van de patiënt musculoskeletaal- of neurologisch van aard of speelt het hart of de longen een belangrijke rol? In ICF termen: Mentale functies, Sensorische functies en pijn, functies van hart en bloedvatenstelsel, hematologisch systeem, afweersysteem en ademhalingsstelsel, functies van bewegingssysteem en aan beweging verwante functies, Functies van huid en verwante structuren.

Additioneel medisch / psychologisch onderzoek
Medisch onderzoek is bijvoorbeeld medische beeldvorming, bloedonderzoek, huisarts/specialist, psychologisch onderzoek, zoals beschreven in de casus of wellicht wat je zelf graag zou willen aanvragen.

ICF classificatie van beschreven en veronderstelde factoren
Zie volgende bladzijde voor invulling RPS (zie tevens de bijlage voor het originele formulier) – Steiner et al. 2002.

RPS form

Naam: **Lft**.: **Geslacht**:

Datum:

Patiënt

Anatomische eigenschappen/ functies ↔ **Activiteiten** ↔ **Participatie**

Therape ut

Persoonlijke factoren | Externe factoren

P

Th

Stap 4 Het gezondheidsprobleem

Het gezondheidsprobleem

Hier leg je vast wat de belangrijkste functioneringsproblemen (stoornissen, activiteiten en participatieproblemen) zijn die je als fysiotherapeut kunt behandelen
In je fysiotherapeutisch handelen zal de nadruk liggen op het behandelen van stoornissen en de daaraan gekoppelde beperking in activiteiten en participatieproblemen (horizontale relatie in RPS formulier).

Stoornis 1	heeft relatie met activiteit 1	en leidt tot participatie 1
Stoornis 2	heeft relatie met activiteit 2	en leidt tot participatie 2
Stoornis 3	etc	

NB Wees ook in staat om omgekeerd te redeneren

Relevante gezondheidsdeterminanten (persoonsgebonden, leefstijl, omgeving):
Benoem een persoonlijke factor (fysieke en psychische persoonlijke factoren) en leg uit waarom die invloed heeft op de horizontale relatie in het RPS formulier.

Benoem een externe factor (iemands fysieke en sociale omgeving) en leg uit waarom die invloed heeft op de horizontale relatie in het RPS formulier.

Achterliggende medisch-biologisch processen van de stoornissen in functies/anatomische eigenschappen:

Leg uit wat de achterliggende medisch biologische processen per stoornis zijn. Doe dit op grond van het geleerde bij TutM, TutF en de hoorcolleges. Zet in eigen woorden de belangrijkste processen neer, tezamen met een verwijzing naar de literatuur (auteur, titel, hoofdstuk, artikel), zodat je het tegen de tijd van je toetsen of na je studie gemakkelijk terug kan vinden.

Stap 5 Diagnostisch proces

Indien patiënt via DTF komt (zonder verwijzing):
Screening pluis/niet pluis: Beschrijf de voor deze casus belangrijkste rode vlaggen (algemeen en regiospecifiek). Denk ook eens na over waar de rode vlag voor bedoeld is (voor welke onderliggende 'ernstige' pathologie).

Indien patiënt via een arts komt:
Welk type medische diagnose is het?
1. Pathologie diagnose: Het substraat dat de ziekte veroorzaakt is bekend
2.Symptoom diagnose: De arts/verwijzer noemt bepaalde verschijnselen van disfunctioneren (vb. pt heeft sinds 3 weken last van lage rugklachten)
3.Syndroomdiagnose: Combinatie van symptomen wordt gedefinieerd als zijnde een ziektebeeld. Definitie is gevormd door consensus onder medici. Denk aan fibromyalgie, migraine e.d.

Indicatie fysiotherapie?
Is de patiënt bij jou aan het goede adres? Is het een indicatie fysiotherapie of stuur je hem terug naar de huisarts voor een verdere voortzetting van het medische traject.

Let op, wanneer een fysiotherapeutische interventie **geen snellere of betere interventie** is dan geen interventie (self limiting), dan is er ook geen fysiotherapeutische indicatie!

Onderzoek
Beschrijf hieronder hoe je het lichamelijk onderzoek zou uitvoeren bij deze casus om een fysiotherapeutische diagnose/conclusie te kunnen trekken. Beschrijf tevens wat de resultaten zouden zijn, zodat een collega fysiotherapeut (i.o.) die dit gedeelte van je 7 stap leest zelf een conclusie zou moeten kunnen vormen.

<u>Anamnese</u>

Hulpvraag (eigen bewoordingen patiënt)

Functioneringsproblemen in eigen bewoordingen patiënt
Vastgelegd worden de belangrijkste functioneringsproblemen die de patiënt zelf ervaart, zoals:

- de aard van de problemen: in termen van stoornissen in functies of anatomische eigenschappen en/of beperkingen in activiteiten en/of participatieproblemen, bijvoorbeeld pijn, adl-problemen, niet kunnen werken en hobby's niet kunnen uitoefenen
- de ernst van de problemen: in de eigen bewoordingen van de patiënt, dan wel vastgesteld via een meetinstrument

Het RPS gedeelte ''volgens patiënt'' moet na je anamnese ingevuld kunnen worden.

Je stelt vragen over de functies en anatomische eigenschappen en de medisch biologische processen die daaraan ten grondslag liggen.

Relevante gezondheidsdeterminanten (persoonsgebonden, leefstijl, omgeving): persoonlijke (fysieke en psychische persoonlijke factoren) en externe factoren (iemands fysieke en sociale omgeving) die het gezondheidsprobleem beïnvloeden; welke vragen stel je hierover?

<u>Inspectie</u>

Welke stoornissen zou je kunnen waarnemen (totale en lokale inspectie)? Geef aan hoe je dit kunt zien. Kan je zien hoe de beperking in activiteit eruit ziet (functionele inspectie)?

Palpatie

Welke stoornissen in functies en anatomische structuren kan je vaststellen d.m.v. palpatie? Leg uit hoe je dit doet.

Functieonderzoek

Je laat de patiënt bewegingen maken (A-ROM) en voert ze zelf nadien ook uit (P-ROM). Hiermee breng je verschillende functies in kaart. Beschrijf hoe de bewegingen tijdens AROM en PROM verlopen.

Beweging	AROM	PROM
Flexie	Pijnlijk in gehele ROM	Geen bijzonderheden
Extensie	Beperkt tot 2° hyperextensie door pijn	Beperkt tot 6° hyperextensie door pijn
Etc	etc	etc

Specifieke testen
Je test een functie of anatomisch eigenschap waarvan je tijdens het bewegingsonderzoek onvoldoende informatie hebt gekregen. Dit geeft meer duidelijkheid over de functies en de oorzaak ervan. Geef aan welke specifieke test je wilt gebruiken en waarvoor. Benoem ook de uitkomstmaat (bijv pijn, eindgevoel, bewegingsuitslag). Beschrijf hoe je de test uitvoert of refereer naar het boek + hoofdstuk/ bladzijde waar deze wordt uitgelegd. Ook kan je meetinstrumenten gebruiken om de omvang van de stoornissen in functies/anatomische eigenschappen, activiteiten en/of participatieproblemen in kaart te brengen.

Fysiotherapeutische conclusie:

Stap 6 Therapeutisch proces

Hoofddoel (sluit aan bij de hulpvraag van de patiënt)
Wat is je hoofddoel? Stel deze SMART op (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgebonden). Je hoofddoel is ten alle tijde op activiteiten niveau gesteld.

Subdoel(en)
Bedenk subdoelen welke tevens SMART geformuleerd zijn. Subdoelen zijn vaak op stoornis niveau. De KNGF richtlijnen geven aan dat de patiënt in ieder geval geïnformeerd moet worden over het gezondheidsprobleem. Deze informatie moet betrekking hebben op alle aspecten van het MDBB-model.

Evaluatieve meetinstrumenten
Welke meetinstrumenten ga je gebruiken om te bekijken of je behandeling effect heeft? Denk aan vragenlijsten zoals de DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand), PSK (Patiënt Specifieke Klachtenlijst), VAS (Visual Analogue Scale) en prestatietesten zoals de 6 MinutenWandelTest (6 MWT), BMI (Body Mass Index), Goniometer. Bedenk goed dat je later in de praktijk verplicht bent om (minimaal 2) meetinstrumenten te gebruiken. Mocht je geen idee hebben, kijk eens in de richtlijnen van het KNGF of http://www.fysiovragenlijst.nl. Geef duidelijk aan wát je meet.

Bijvoorbeeld:

Mobiliteit (functie)	Goniometer
Pijn (functie)	NRS (Nummeric Rating Scale)
Disfunctioneren schouder (activiteitenniveau):	DASH (Disabilities of Arm Shoulder and Hand)

Behandelmethode

Informeren en adviseren:

Geef hier aan welke informatie aan de patiënt verstrekt moet worden zodat het duidelijk wordt wat het gezondheidsprobleem is zodat de patiënt mede het besluit kan nemen over de keuze van de therapie. Gebruik hierbij onder andere het MDBB-model en leg de relatie tussen aspecten in dit model en het gezondheidsprobleem. Geef adviezen aan de patiënt hoe hij het beste om kan gaan met zijn of haar gezondheidsprobleem.

Oefenen en sturen, Manuele verrichtingen, Massage, Fysische therapie in de engere zin:

Vul in het overzicht de gekozen stoornissen, activiteiten en participatieproblemen in uit stap 4. In het overzicht geef je aan hoe je ze gaat behandelen. Je kunt uiteraard kiezen uit passieve en actieve behandelsoorten, oftewel hands-on technieken en hands-off technieken. Hieronder zie je een voorbeeld van een ingevuld overzicht.

	Behandelsoort passief (hands-on)	Behandelsoort actief (hands-off)	ADL / Sport / Werk
Stoornis 1	Massage	Stabiliteitstraining	A,S,W
Stoornis 2	Tractie vgl Kaltenborn	HOS - rekken	A,S,W
Activiteit 1	-	Oefentherapie	A
Participatie 1	-		

Behandeltechnieken
Leg hier kort uit hoe je de behandeltechnieken uitvoert. Indien je parameters weet en/of hulpmiddelen inzet zet deze er dan bij. Verwijs naar de verplichte literatuur (boek, auteur, hoofdstuk/bladzijde).

Bijvoorbeeld:

Stabiliteitstraining	D.m.v. de Stabilizer core stabiliteit aanleren, zie Kisner & Colby, blz X t/Z.
Massage	Effleurages van de scapula-thoracale musculatuur hfst x uit Y.
Werp ABC	Opbouwend volgens v/d Goolberg, Rehaboom, blz Y.

Hulpmiddelen
Welke hulpmiddelen zou de patiënt kunnen gebruiken gericht op stoornissen, activiteit, participatie en de omgeving? Denk aan bijv. krukken, sta op stoel. Indien niet van belang bij deze casus, noteer hier ‘geen bijzonderheden’.

Interventie door anderen (multidisciplinair)
Is er een interventie nodig uitgevoerd door andere zorgverleners? Denk aan een psycholoog, ergotherapeut. Indien dit niet nodig is, noteer dan ‘geen bijzonderheden’.

Stap 7 Effect van de therapie

Informeren en adviseren
Welke invloed heeft het informeren en adviseren gehad op het gezondheidsprobleem? Leg dit kort uit.

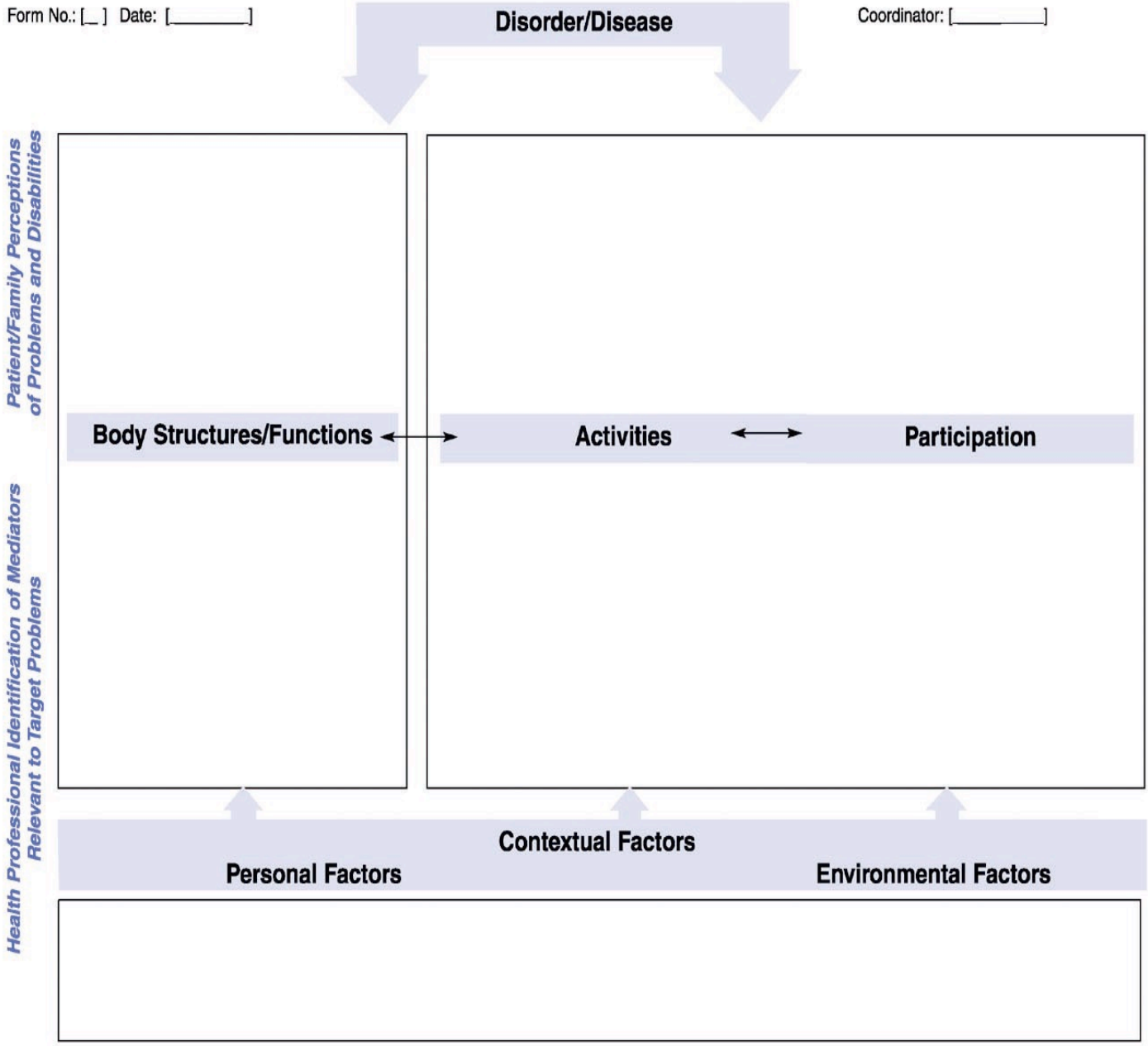
Behandeling passief/actief
Geef aan hoe je interventie effect heeft op de gekozen functies/anatomische eigenschappen, de activiteiten en de participatieproblemen uit stap 4 en 6. Leg uit hoe je interventie primair werkt. Zorg ervoor dat je je behandeling altijd kan uitleggen aan je patiënt en aan collega's.

Voorbeeld:

1. Verbeteren spierkracht dmv recrutering
   Recruteren van meer motor units houdt in dat we de spier gaan trainen, zodat er op neurogeen niveau meer 'spiersectoren' worden geactiveerd en er zo meer spierkracht ontstaat.
2. Het gebruik van het Mulligan concept voor pijndemping en vergroten van de beweeglijkheid. Het bewegingssegment wordt in een natuurlijk pijnvrij bewegingsverloop begeleid. Hierdoor vindt pijnmodulatie plaats.

Pat. No. [_____]

Medication: [_____]

Form No.: [_] Date: [_____]

Coordinator: [_____]